

TEMA 1.1

Manejo de Urgencias en Arritmias

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Inestabilidad hemodinámica (hipotensión, choque, dolor isquémico, edema pulmonar agudo o alteración de conciencia) requiere cardioversión eléctrica sincronizada inmediata en taquiarritmias.
- En bradiarritmias sintomáticas o inestables, el tratamiento farmacológico inicial es Atropina 0.5 - 1 mg EV bolo, preparando marcapaso transcutáneo.
- Taquicardia de complejo QRS angosto ($<0.12s$) estable: 1° Maniobras vagales (Valsalva modificada), 2° Adenosina 6 mg EV bolo rápido.
- Taquicardia de complejo QRS ancho ($\geq 0.12s$) en adulto con antecedentes cardiovasculares debe manejarse como Taquicardia Ventricular hasta demostrar lo contrario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 60 años con antecedente de estenosis mitral severa e hipertensión arterial, ingresa a urgencias por disnea de reposo y palpitations de inicio brusco hace 2 horas. Al examen físico: paciente soporosa, pálida y sudorosa; PA 82/40 mmHg, FC 145x' irregular, MP(+) con crépitos difusos en ambos campos pulmonares y soplo diastólico IV/VI en ápex. ECG confirma Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida."

Piensa en: Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida y descompensación hemodinámica aguda (Shock cardiogénico + Edema agudo pulmonar).

Conducta: Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata con 120-200 Joules previa sedación rápida si la conciencia lo permite.

Definición y Concepto Fundamental

El manejo de urgencia en arritmias comprende el conjunto de medidas diagnósticas y terapéuticas inmediatas orientadas a estabilizar al paciente que cursa con un trastorno del ritmo cardíaco asociado a riesgo vital inminente o deterioro hemodinámico severo. La premisa fundamental en la medicina de urgencia no es el diagnóstico electrocardiográfico exacto inicial, sino la determinación del estado de perfusión tisular y la presencia de inestabilidad hemodinámica.

Fisiopatología de la Inestabilidad Hemodinámica

Tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias severas alteran el gasto cardíaco. En las taquiarritmias severas (frecuencias $> 150x'$), el tiempo de llenado diastólico del ventrículo izquierdo disminuye drásticamente, lo que reduce el volumen sistólico, colapsa el gasto cardíaco y disminuye la perfusión de las arterias coronarias. En las bradiarritmias severas (frecuencias $< 40x'$), la frecuencia extremadamente baja es insuficiente para mantener el gasto cardíaco mínimo requerido por los órganos nobles.

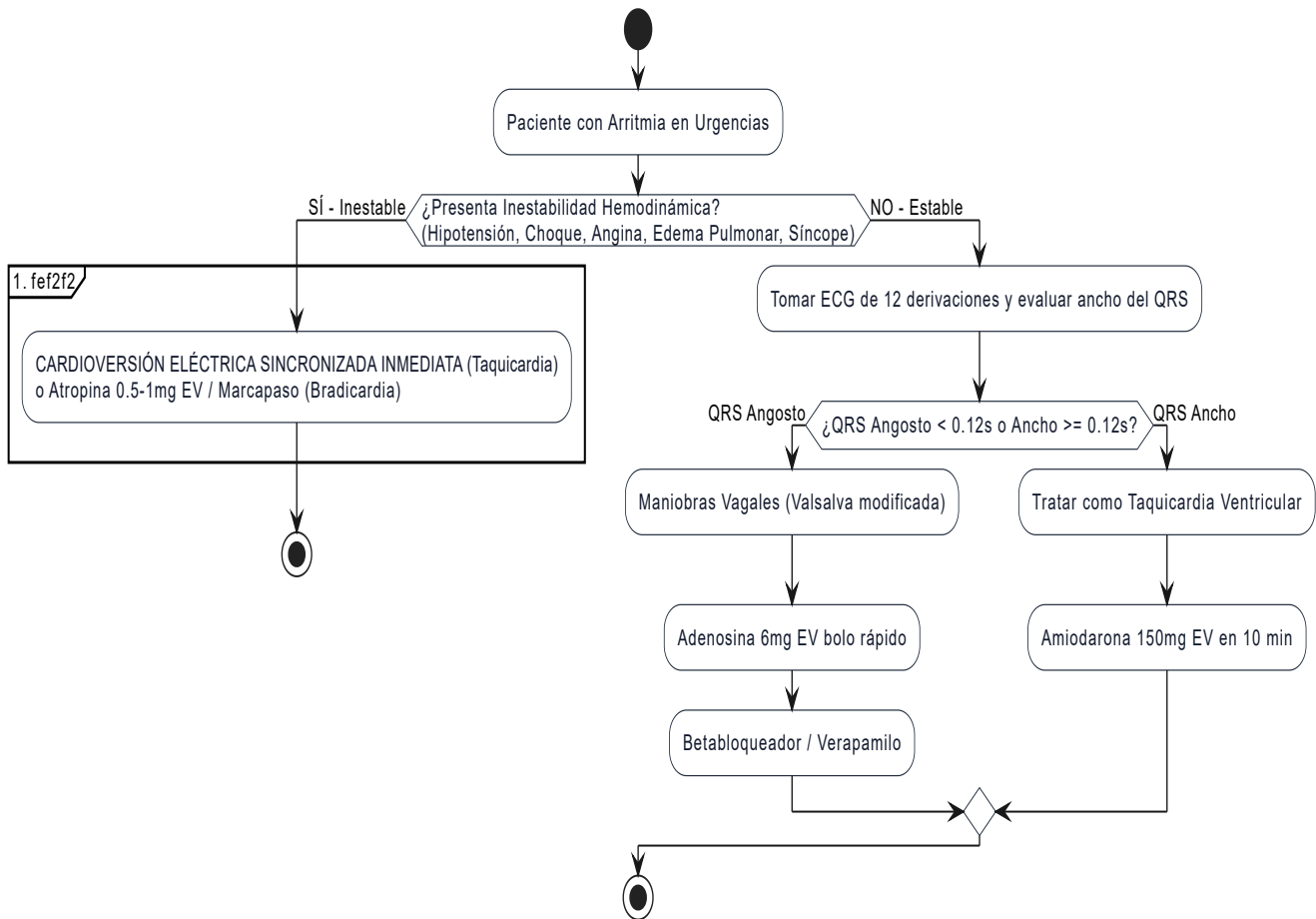
Criterios Clínicos de Inestabilidad (Los 4 Signos Cardinales)

Ante cualquier arritmia en urgencias, debe buscarse activamente la presencia de al menos uno de los siguientes 4 criterios de inestabilidad:

- **Signos de Choque / Hipotensión:** Presión arterial sistólica < 90 mmHg, PAM < 65 mmHg, frialdad distal o llenado capilar lento.
- **Alteración Aguda del Estado Mental:** Somnolencia, confusión o síncope secundario a hipoperfusión cerebral.
- **Isquemia Miocárdica Activa:** Dolor torácico opresivo de características anginosas o cambios isquémicos en el ECG.
- **Insuficiencia Cardíaca Aguda:** Congestión pulmonar franca (crépitos bibasales difusos, ortopnea, edema pulmonar agudo).

ALGORITMO DE EVALUACIÓN Y MANEJO AGUDO DE ARRITMIAS

Please use 'loption handwritten true' to enable handwritten



ALGORITMO DE EVALUACIÓN Y MANEJO AGUDO DE ARRITMIAS — RESUMEN PARALELO

MANEJO INESTABLE (URGENCIA)

Criterios de Inestabilidad:

Hipotensión (PAS < 90 mmHg), Choque, Angina activa, Edema pulmonar agudo o Alteración de conciencia.



CONDUCTA INMEDIATA:

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA SINCRONIZADA

MANEJO ESTABLE (ESCALONADO)

Criterios de Estabilidad:

Sin signos de choque, sin angina, sin congestión pulmonar y sensorio conservado.



ESQUEMA PASO A PASO:

INMEDIATA (Taquicardia)
o Atropina 0.5-1mg EV + Marcapaso Transcutáneo (Bradicardia).

Paso 1: Tomar ECG de 12 derivaciones y evaluar ancho del QRS.

Paso 2: QRS Angosto (<0.12s): Maniobras vagales -> Adenosina 6mg EV -> Betabloqueador / Verapamilo.

Paso 3: QRS Ancho (>=0.12s): Tratar como Taquicardia Ventricular -> Amiodarona 150mg EV en 10 min.

FÁRMACOS CLAVE EN MANEJO DE URGENCIAS EN ARRITMIAS

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adenosina	TPSV regular de complejo angosto estable	6 mg EV bolo rápido en vena antecubital + 20 ml SF	Contraindicada en asma severo. Causa rubor y pausa asistólica corta.
Amiodarona	TV monomórfica estable / FA descompensada	150 mg EV en 10 min, infusión 1 mg/min x 6h	Hipotensión arterial, bradicardia. Monitorizar QT.
Atropina	Bradiarritmia sintomática / BAV nodal	0.5 - 1 mg EV bolo (repetir c/3-5 min max 3mg)	Ineficaz en BAV infranodal (Mobitz II / BAV 3° alto).

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 11

Mujer de 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, RI2T con soplo diastólico IV/VI en ápex. La conducta inicial más adecuada es:

- A) Administrar amiodarona endovenosa en bolo
- B) Entregar oxígeno a FiO2 elevadas y soporte ventilatorio con BiPAP
- C) Reponer fluidos con suero fisiológico
- D) Cardioversión eléctrica inmediata
- E) Administrar furosemida endovenosa asociada a drogas vasoactivas

Respuesta Correcta: D

Paciente hemodinámicamente inestable (PA 85/35 mmHg) por taquiarritmia con edema pulmonar agudo. La indicación absoluta de primera línea es la cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

EUNACOM TIP

En el examen EUNACOM, si un paciente con arritmia tiene hipotensión o edema pulmonar, la respuesta correcta SIEMPRE es cardioversión eléctrica. No intente fármacos primero.

DATO CLAVE

Sincronizar el cardioversor con la onda R es vital para evitar descargar sobre la onda T y precipitar una Fibrilación Ventricular (fenómeno R sobre T).

MINSAL GES

El protocolo SAMU / Red de Urgencia exige monitor con parches de desfibrilación instalados antes del traslado de todo paciente arritmico inestable.

PERLAS CLÍNICAS

- En taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular se realiza DESFIBRILACIÓN NO SINCRONIZADA inmediata.
- La dosis de adenosina debe administrarse mediante técnica de dos llaves (bolo rápido de fármaco seguido inmediatamente de 20 ml de SF y elevación del brazo).
- En bradiarritmias por sobredosis de betabloqueadores el antídoto específico es el Glucagón EV.

TEMA 1.2

Paro Cardiorespiratorio

PERFIL EUNACOM 1.01.2.006

Paro cardiorespiratorio

Dx: Específico Tx: Completo Seg: Derivar

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Diagnóstico de Paro: Paciente inconsciente + no responde + no respira normalmente (o solo gadea/gasping) + ausencia de pulso carotídeo comprobada en < 10 segundos.
- Ritmos Desfibrilables: Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TVsp). La desfibrilación precoz es el determinante principal de supervivencia.
- Ritmos NO Desfibrilables: Asistolia y Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP). Requieren RCP inmediata y Adrenalina precoz.
- Calidad de las Compresiones: Frecuencia 100-120/min, profundidad 5-6 cm, permitir reexpansión torácica completa, minimizar interrupciones (<10s).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 58 años, hipertenso y fumador, se desploma súbitamente en el pasillo del servicio de urgencias. Al evaluarlo, no responde a llamadas ni estímulo doloroso, y no se palpa pulso carotídeo en 5 segundos. Se instala monitor desfibrilador que muestra una actividad eléctrica caótica e irregular de amplitud variable sin complejos QRS reconocibles."

Piensa en: Paro Cardiorespiratorio en Fibrilación Ventricular (Ritmo desfibrilable).

Conducta: Iniciar compresiones torácicas inmediatamente mientras se carga el desfibrilador → Aplicar descarga de 200 Joules (bifásico) e inmediatamente reiniciar RCP por 2 minutos.

Definición y Etiología del Paro Cardiorespiratorio (PCR)

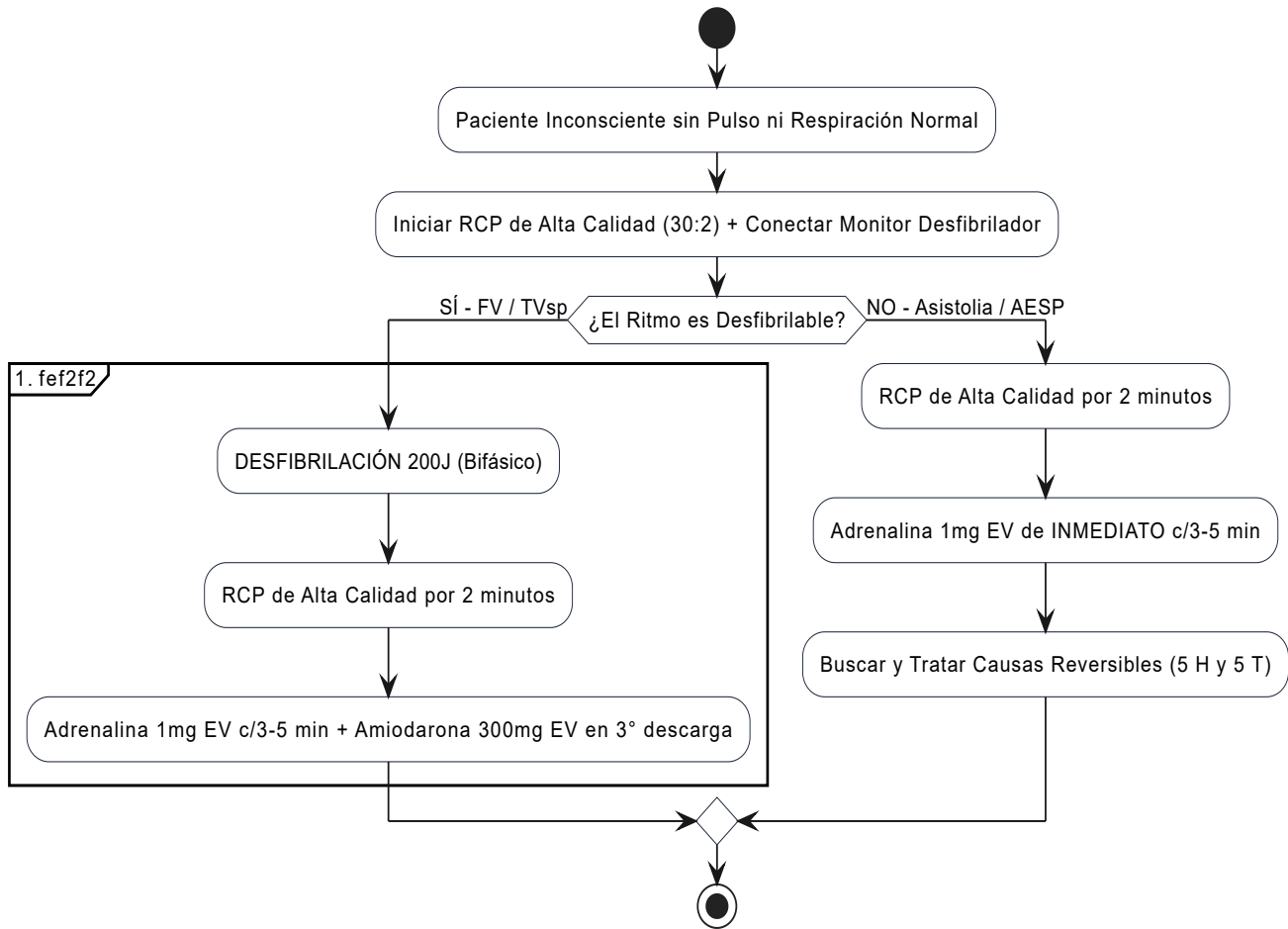
El paro cardiorespiratorio es la cesación brusca e inesperada de la actividad mecánica cardíaca y de la respiración espontánea. En adultos, más del 80% de los casos de PCR son de causa cardíaca primaria, siendo la cardiopatía coronaria agudizada la etiología más frecuente.

Fisiopatología de los Ritmos de Paro

Los ritmos de PCR se dividen en Desfibrilables (FV / TVsp) y NO Desfibrilables (Asistolia / AESP). La asistolia representa la ausencia total de actividad eléctrica. La AESP presenta despolarización eléctrica sin contracción mecánica efectiva.

ALGORITMO GENERAL DE SOPORTE VITAL AVANZADO (ACLS)

Please use 'loption handwritten true' to enable handwritten



ALGORITMO GENERAL DE SOPORTE VITAL AVANZADO (ACLS) — RESUMEN PARALELO

MANEJO INESTABLE (URGENCIA)

Criterios de Inestabilidad:

Ritmo Desfibrilable (FV / TVsp) en paciente en paro.



CONDUCTA INMEDIATA:

DESFIBRILACIÓN 200J BIFÁSICO INMEDIATA + RCP 2 min + Adrenalina 1mg EV c/3-5 min.

MANEJO ESTABLE (ESCALONADO)

Criterios de Estabilidad:

Ritmo NO Desfibrilable (Asistolia / AESP).



ESQUEMA PASO A PASO:

Paso 1: RCP de Alta Calidad por 2 minutos.

Paso 2: Adrenalina 1mg EV de INMEDIATO c/3-5 min.

Paso 3: Buscar y Tratar Causas Reversibles (5 H y 5 T).

FÁRMACOS CLAVE EN PARO CARDIORESPIRATORIO

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adrenalina	PCR (Todos los ritmos)	1 mg EV bolo c/3-5 min (1:10.000)	En asistolia/AESP dar de inmediato. En FV/TVsp dar tras la 2° descarga.
Amiodarona	FV / TVsp refractaria a descargas	1° dosis 300 mg EV bolo, 2° dosis 150 mg	Administrar tras la 3° descarga si persiste el ritmo desfibrilable.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 19

Paciente de 58 años sufre paro cardíaco presenciado. Se inicia RCP y el monitor demuestra asistolia. La medida farmacológica más adecuada e inmediata es:

- A) Administrar atropina 1 mg EV
- B) Administrar amiodarona 300 mg EV
- C) Administrar adrenalina 1 mg EV
- D) Realizar choque eléctrico de 200J
- E) Administrar bicarbonato de sodio 1 mEq/kg

Respuesta Correcta: C

En ritmos NO desfibrilables (asistolia y AESP), la adrenalina 1 mg EV debe administrarse lo antes posible junto con la RCP de alta calidad.

EUNACOM TIP

En asistolia NUNCA desfibrilar. Confirmar el trazado en al menos 2 derivaciones y buscar causas 5H y 5T.

DATO CLAVE

La capnografía cuantitativa (ETCO₂) monitoriza la calidad de las compresiones. Un valor < 10 mmHg indica RCP ineficaz.

PERLAS CLÍNICAS

- Frecuencia de ventilación tras intubación endotraqueal: 1 ventilación cada 6 segundos (10 por minuto) sin pausar compresiones.
- La causa reversible más común de AESP en pacientes traumatizados o hipotensos es la hipovolemia severa.

TEMA 1.4

Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos

PERFIL EUNACOM 1.01.1.002

Bloqueos aurículo-ventriculares

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- BAV de 1° Grado: PR > 0.20 segundos constante. Todas las ondas P conducen. Generalmente benigno y asintomático.
- BAV de 2° Grado Mobitz I (Wenckebach): Prolongación progresiva del PR hasta que una onda P no conduce. Sitio de bloqueo: Nódulo AV. Generalmente benigno.
- BAV de 2° Grado Mobitz II: PR constante con falla intermitente e impredecible de la conducción P. Sitio de bloqueo: Infranodal. Alto riesgo de progresión a BAV 3° -> Requiere Marcapaso Definitivo.
- BAV de 3° Grado (Completo): Disociación AV completa. Ondas P y complejos QRS laten de forma totalmente independiente -> Marcapaso Definitivo Garantizado (GES N° 25).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 74 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, consulta por episodios de mareos profundos y dos eventos sincopales en el último mes. Al examen físico: FC 34x' regular, PA 145/80 mmHg. El electrocardiograma revela ondas P a 75x' y complejos QRS anchos a 34x', sin ninguna relación temporal entre las P y los QRS."

Piensa en: Bloqueo Auriculoventricular Completo (BAV de 3° Grado) con ritmo de escape idioventricular.

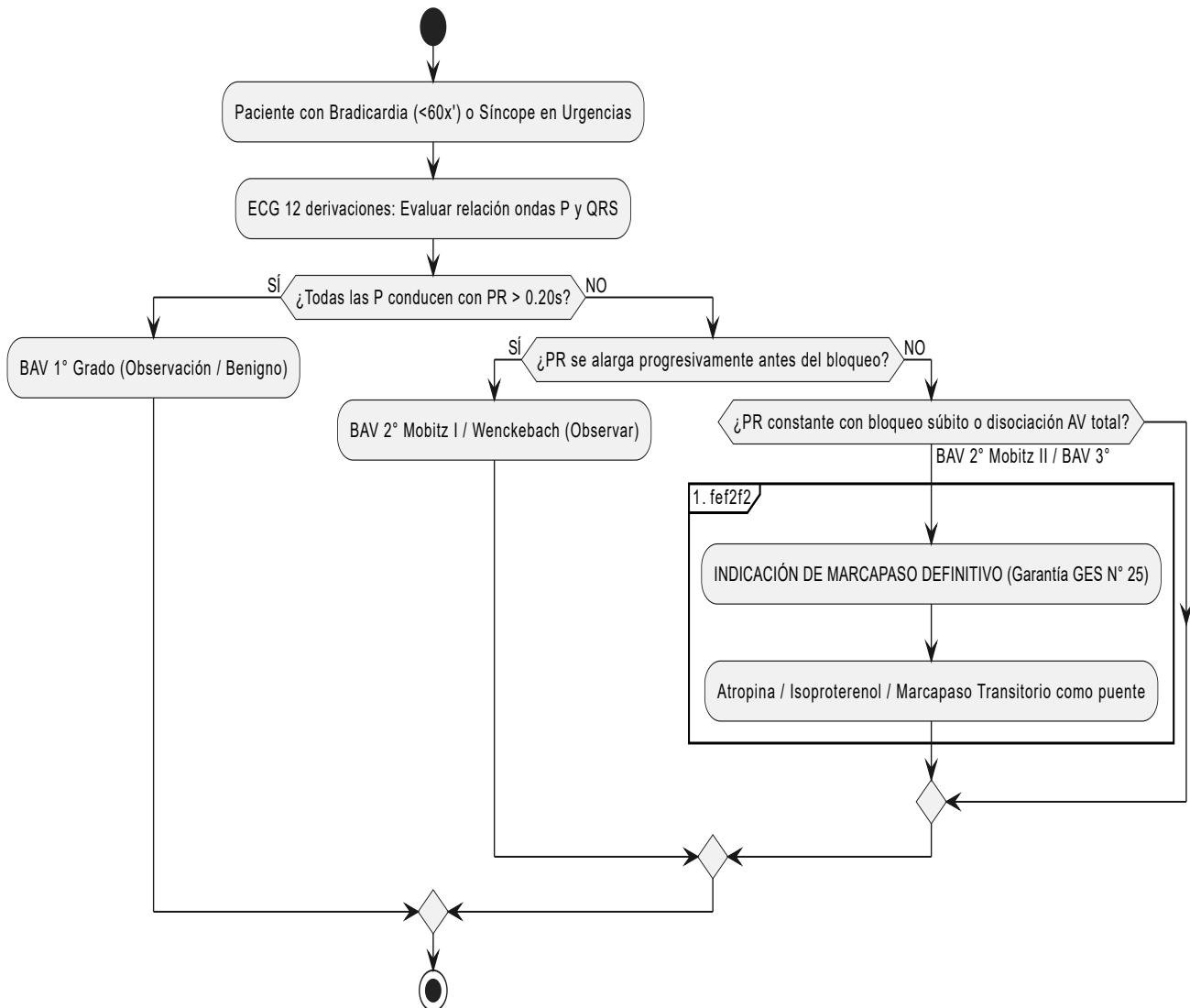
Conducta: Hospitalizar en unidad monitorizada, instalar marcapaso transitorio si presenta inestabilidad y gestionar implante de Marcapaso Definitivo (Garantía GES N° 25).

Fisiopatología de los Trastornos de la Conducción AV

Los bloqueos auriculoventriculares ocurren por una alteración anatómica o funcional en el sistema de conducción cardíaco que retarda o interrumpe la transmisión del impulso eléctrico desde las aurículas hacia los ventrículos. El sitio anatómico del bloqueo (nodal vs infranodal) determina el pronóstico y la respuesta a fármacos vagolíticos.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE BLOQUEOS AV

Please use 'loption handwritten true' to enable handwritten



ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE BLOQUEOS AV — RESUMEN PARALELO

MANEJO INESTABLE (URGENCIA)

Criterios de Inestabilidad:

BAV de 2° Grado Mobitz II o BAV de 3° Grado (Completo).



MANEJO ESTABLE (ESCALONADO)

Criterios de Estabilidad:

BAV de 1° Grado o BAV 2° Mobitz I asintomático.



CONDUCTA INMEDIATA:

INDICACIÓN DE MARCAPASO DEFINITIVO (Garantía GES N° 25).

Atropina / Isoproterenol / Marcapaso Transitorio como puente.

ESQUEMA PASO A PASO:

Paso 1: BAV 1° Grado: Observación y seguimiento ambulatorio.

Paso 2: BAV 2° Mobitz I: Tratamiento etiológico y descarte de fármacos bradicardizantes.

FÁRMACOS CLAVE EN BRADIARRITMIAS Y BLOQUEOS CARDÍACOS

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Atropina	Bradicardia sinusal / BAV Nodal (1° Grado / Mobitz I)	0.5 - 1 mg EV bolo c/3- 5 min (máx 3 mg)	Ineficaz en bloqueos infranodales (Mobitz II / BAV 3° infranodal).

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA**Pregunta 7**

Paciente de 72 años con antecedentes de HTA y diabetes, ingresa por episodio sincopal sin traumatismo. Al ECG se evidencia ritmo sinusal con FC 35x', ondas P independientes de los complejos QRS, los cuales son anchos (QRS 0.14s). El diagnóstico y manejo de elección es:

- A) BAV 2° Mobitz I - Observación clínica
- B) BAV 1° Grado - Atropina EV a permanencia
- C) Enfermedad del nodo sinusal - Amiodarona EV
- D) BAV 3° Grado - Instalación de marcapaso definitivo
- E) Bloqueo completo de rama izquierda - Coronariografía urgente

Respuesta Correcta: D

Disociación AV en paciente sincopal es BAV 3° Grado. Tratamiento definitivo: Marcapaso Definitivo (GES N° 25).

GES CHILE

GES N° 25: Trastornos de conducción en mayores de 15 años que requieren marcapaso definitivo están garantizados con cobertura financiera y plazos legales.

EUNACOM TIP

Si en una pregunta del EUNACOM mencionan un paciente mayor con síncope y QRS ancho con FC 30-35x' -> Pensar en BAV 3° y marcar Marcapaso Definitivo.

PERLAS CLÍNICAS

- El infarto agudo de miocardio de pared inferior suele cursar con BAV de 2° Mobitz I o BAV 3° nodal transitorio que responde a Atropina.
- La hiperkalemia es la causa metabólica reversible más frecuente de bradicardia con ensanchamiento progresivo del QRS.

TEMA 1.5**Fibrilación Auricular****PERFIL EUNACOM 1.01.1.012**

Fibrilación auricular crónica

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- La arritmia cardíaca sostenida más frecuente en la práctica médica global. Su principal causa etiológica es la Hipertensión Arterial (HTA).
- Hallazgos Patognomónicos en el ECG: Ausencia total de ondas P (reemplazadas por ondas 'f' de fibrilación) e intervalos R-R irregularmente irregulares.

- Complicación Cardinal: Embolia sistémica (Accidente Cerebrovascular Isquémico) por formación de trombos en la orejuela de la aurícula izquierda.
- Estratificación Antitrombótica: Escala CHA₂DS₂-VASc indica necesidad de Anticoagulación Oral (ACO) a permanencia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

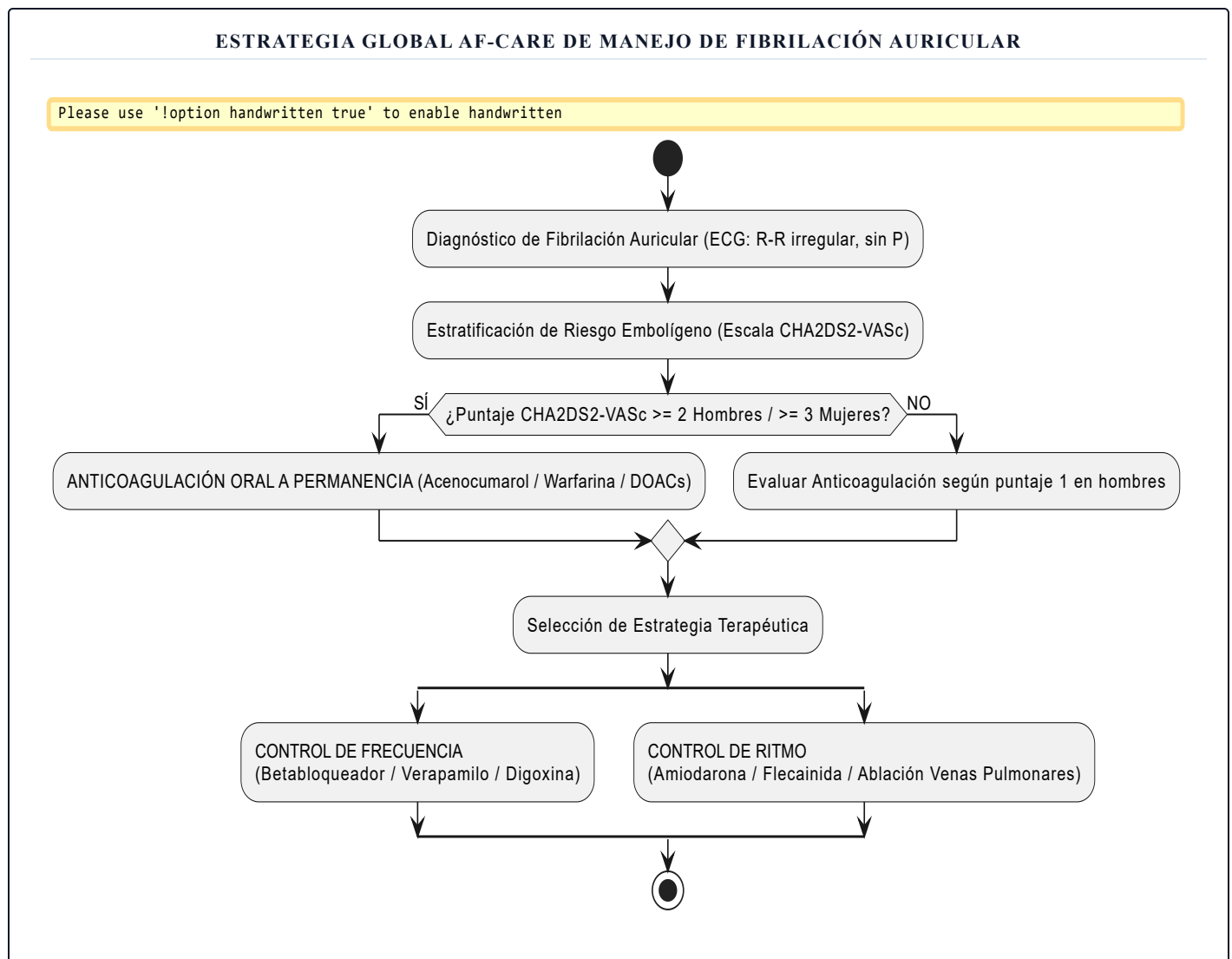
"Mujer de 68 años, hipertensa en tratamiento con enalapril, consulta por palpitaciones de 2 semanas de evolución asociadas a fatiga de esfuerzo. Examen físico: PA 138/84 mmHg, FC 118x' irregular. Pulso arterial deficitario. Sin signos de congestión pulmonar. ECG confirma Fibrilación Auricular."

Piensa en: Fibrilación Auricular no valvular hemodinámicamente estable.

Conducta: Calcular CHA₂DS₂-VASc (3 puntos: HTA + Edad 65-74 + Sexo Femenino) -> Iniciar Anticoagulación Oral a permanencia + Betabloqueador para control de FC.

Fisiopatología y Remodelado Auricular

La Fibrilación Auricular (FA) se origina por la presencia de múltiples micro-reentradas auriculares impulsadas por focos ectópicos automáticos localizados predominantemente en la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. La sobrecarga de presión (HTA) o de volumen causa dilatación auricular, fibrosis miocárdica y remodelado eléctrico/estructural que perpetúa la arritmia.



ESTRATEGIA GLOBAL AF-CARE DE MANEJO DE FIBRILACIÓN AURICULAR — RESUMEN PARALELO

MANEJO INESTABLE (URGENCIA)

Criterios de Inestabilidad:

Hipotensión, síncope, shock cardiogénico o edema pulmonar agudo.



CONDUCTA INMEDIATA:

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA SINCRONIZADA INMEDIATA (120-200J).

MANEJO ESTABLE (ESCALONADO)

Criterios de Estabilidad:

Paciente en buenas condiciones hemodinámicas.



ESQUEMA PASO A PASO:

Paso 1: Calcular Escala CHA₂DS₂-VASc.

Paso 2: Si CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 (hombres) / ≥ 3 (mujeres): Anticoagulación Oral a permanencia.

Paso 3: Seleccionar Estrategia: Control de Frecuencia (Betabloqueador / Verapamilo) vs Control de Ritmo (Amiodarona / Flecainida).

FÁRMACOS CLAVE EN FIBRILACIÓN AURICULAR

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Bisoprolol / Carvedilol	Control de FC en FA (1º Línea)	Bisoprolol 2.5 - 10 mg/día VO	Evitar en asma severo descompensado y bradicardia.
Acenocumarol / Warfarina	Anticoagulación en FA (Estándar APS Chile)	Ajustada por INR (Meta 2.0 - 3.0)	Requiere controles periódicos de coagulación.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 6

Mujer de 65 años, hipertensa en tratamiento con enalapril, consulta por palpitaciones e intolerancia al esfuerzo de 3 semanas de evolución. ECG demuestra fibrilación auricular con FC 110x'. Ecocardiograma muestra aurícula izquierda de 44 mm y FE 55%. Su puntaje CHA₂DS₂-VASc es de 3 puntos. La conducta antitrombótica más adecuada es:

- A) Aspirina 100 mg/día
- B) Clopidogrel 75 mg/día
- C) Anticoagulación oral a permanencia
- D) Doble terapia antiagregante con aspirina y clopidogrel
- E) No requiere tratamiento antitrombótico

Respuesta Correcta: C

En FA no valvular con CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 en hombres o ≥ 3 en mujeres, existe indicación absoluta de Anticoagulación Oral a permanencia.

MINSAL 2018

En la red pública de Chile (FONASA/APS), el Acenocumarol es el anticoagulante de primera línea entregado en el Programa de Salud Cardiovascular.

EUNACOM TIP

FA Valvular (Estenosis Mitral moderada/severa o Prótesis Mecánica) REQUIERE anticoagulación obligatoria con Warfarina/Acenocumarol. Los DOACs están contraindicados.

PERLAS CLÍNICAS

- El uso de Aspirina para prevención de stroke en FA no valvular está descatalogado por falta de eficacia frente al riesgo hemorrágico.
- La FA silente o asintomática tiene el mismo riesgo de provocar un ACV embólico que la FA sintomática.

TEMA 1.12

Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)

PERFIL EUNACOM 1.01.1.024

Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Taquicardia regular de complejo QRS angosto ($<0.12s$) más frecuente en pacientes jóvenes sin cardiopatía.
- Mecanismos principales: 1) Reentrada Nodal AV (60%). 2) Reentrada Auriculoventricular por Vía Accesorio (WPW) (30%).
- Clínica: Palpitaciones de inicio y término BRUSCO, cuello latiente (signo de la rana).
- Tratamiento Agudo: 1° Maniobras Vagales (Valsalva modificada). 2° Adenosina 6 mg EV en bolo rápido. 3° Cardioversión Eléctrica si inestable.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 28 años sin antecedentes consulta a urgencias por episodio de palpitaciones intensas de inicio brusco mientras estudiaba. FC 185x', PA 115/75. ECG muestra taquicardia regular de QRS angosto sin ondas P visibles."

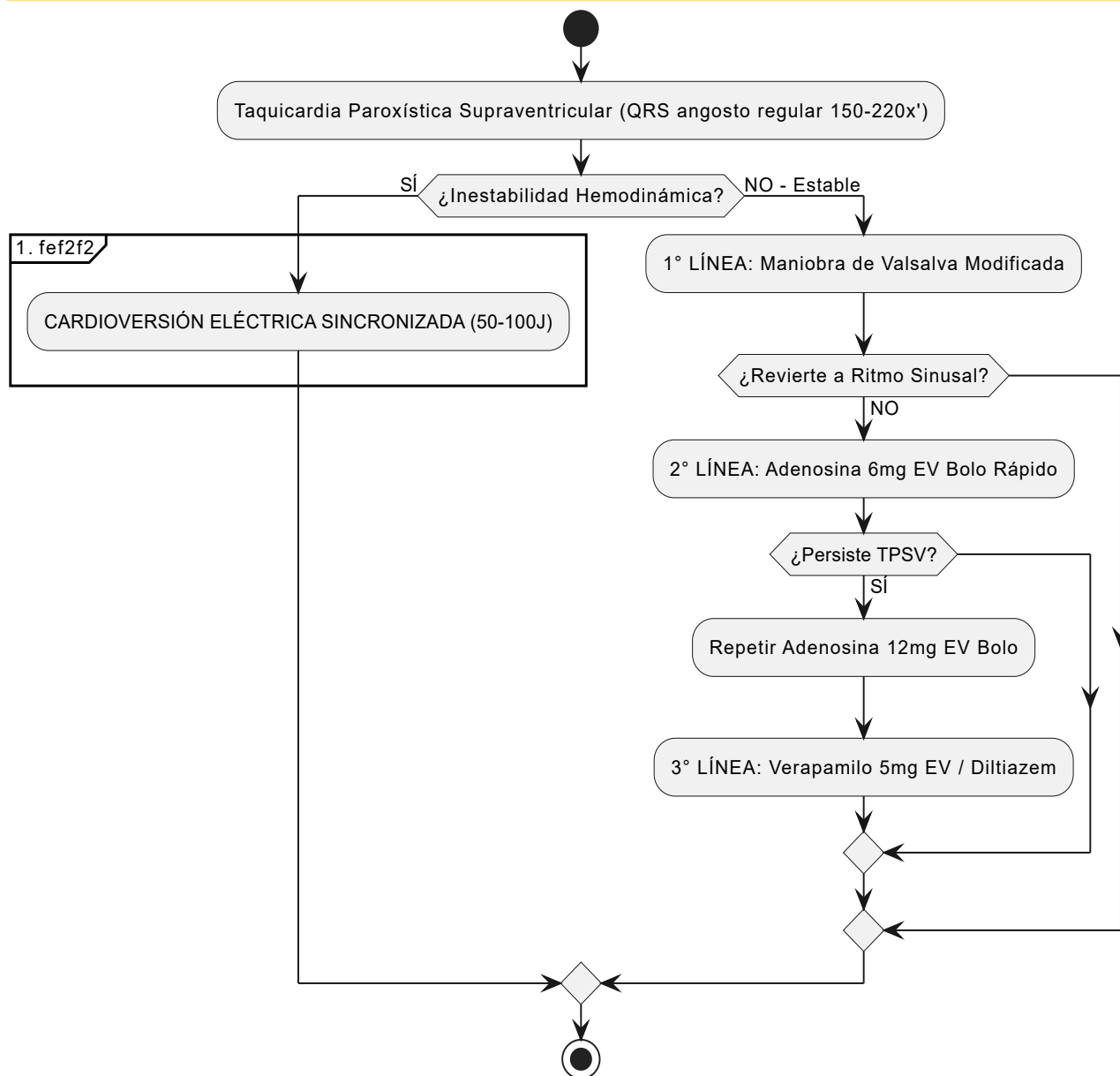
Piensa en: Taquicardia Paroxística Supraventricular por Reentrada Nodal.

Conducta: Realizar Maniobras Vagales (Valsalva modificada). Si no cede, administrar Adenosina 6 mg EV en bolo rápido.

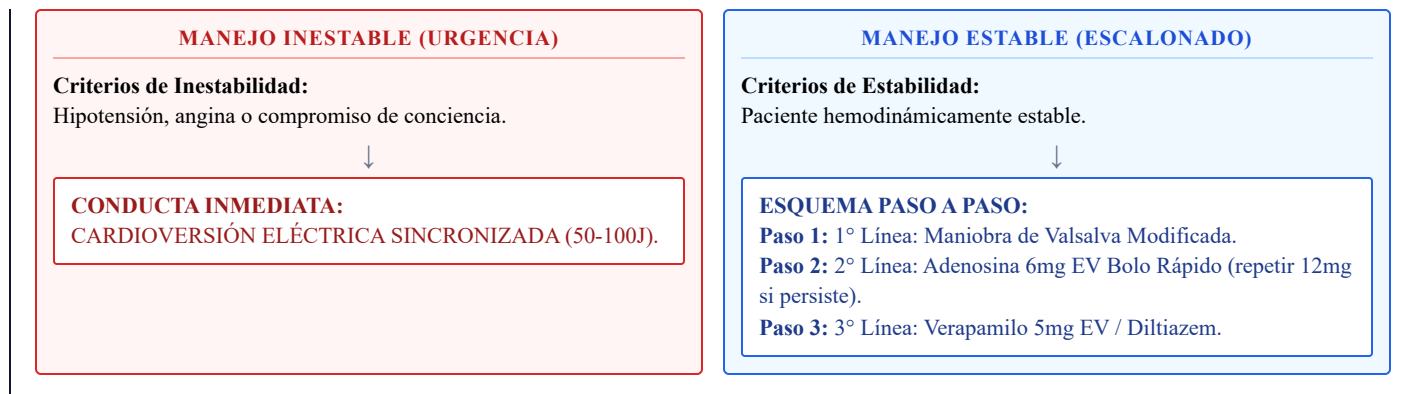
Fisiopatología de la Reentrada Nodal AV

La Taquicardia por Reentrada Nodal Auriculoventricular (TRNAV) ocurre en corazones sin enfermedad estructural por la existencia de una doble vía de conducción dentro del nódulo AV: una vía rápida de período refractario largo y una vía lenta de período refractario corto. Un extrasístole auricular desencadena el circuito de reentrada.

ALGORITMO DE MANEJO DE TPSV EN URGENCIAS



ALGORITMO DE MANEJO DE TPSV EN URGENCIAS — RESUMEN PARALELO



FÁRMACOS CLAVE EN TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR (TPSV)

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adenosina	1° opción farmacológica en TPSV	6 mg EV bolo rápido -> 12 mg EV	Contraindicada en asma severo.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 8

Mujer de 30 años con palpitaciones muy intensas de inicio y término brusco de minutos de duración. Ingresa a urgencias por palpitaciones. Al examen: FC:180x', PA:110/70. El ECG muestra taquicardia regular a QRS angosto. La primera medida a seguir es:

- A) Administrar adenosina endovenosa
- B) Administrar amiodarona endovenosa
- C) Realizar cardioversión eléctrica
- D) Realizar maniobras vagales
- E) Administrar propafenona oral

Respuesta Correcta: D

En TPSV regular a QRS angosto hemodinámicamente estable, la primera medida no invasiva son las maniobras vagales.

EUNACOM TIP

Paciente joven con TPSV estable -> La PRIMERA MEDIDA a realizar son las Maniobras Vagales.

PERLAS CLÍNICAS

- En WPW con Fibrilación Auricular está CONTRAINDICADO usar Verapamilo, Adenosina o Digoxina.

TEMA 1.13

TV y Canalopatías

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Taquicardia ventricular / Canalopatías

Dx: Sospecha Tx: Inicial Seg: Derivar

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Taquicardia de QRS Ancho ($\geq 0.12s$): Toda taquicardia de QRS ancho en adulto con cardiopatía debe considerarse Taquicardia Ventricular (TV) hasta demostrar lo contrario.
- TV Monomórfica Estable: Amiodarona 150 mg EV en 10 min o Procainamida. Si se inestabiliza -> Cardioversión Eléctrica.

- Canalopatías: Síndrome de QT Largo (riesgo de Torsades de Pointes), Síndrome de Brugada (ST ensillado en V1-V3).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

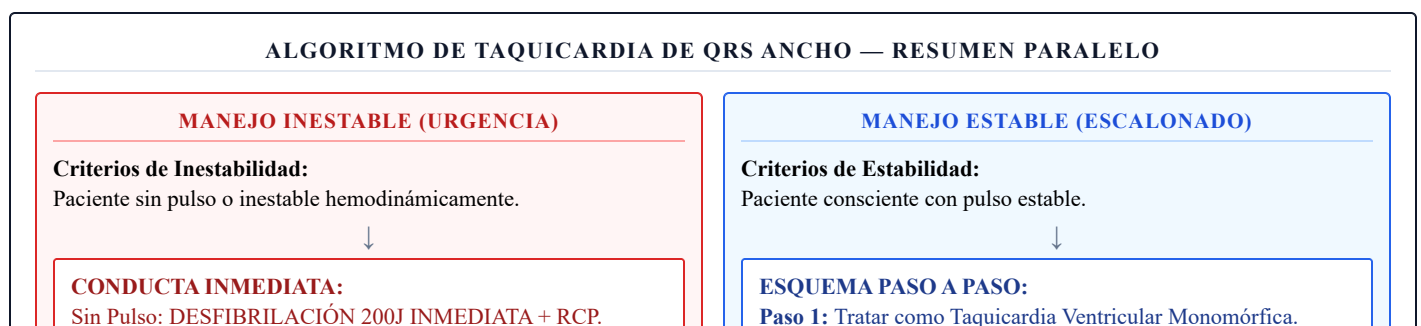
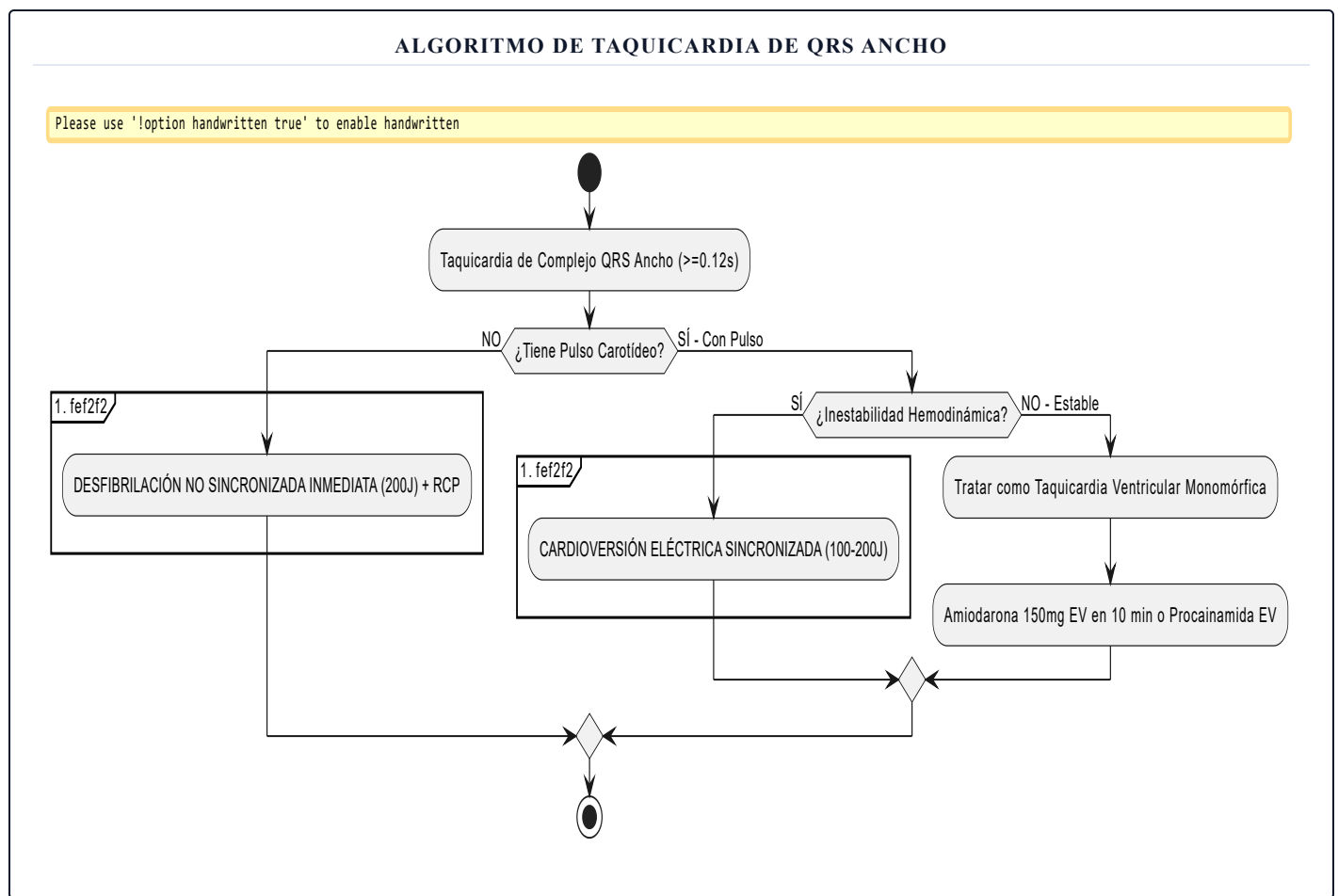
"Hombre de 65 años con antecedente de infarto miocárdico antiguo presenta palpitaciones y mareos. PA 105/65, FC 170x'. ECG muestra taquicardia regular de complejo QRS ancho (0.16s) con disociación AV."

Piensa en: Taquicardia Ventricular Monomórfica Sostenida.

Conducta: Amiodarona 150 mg EV en 10 min si estable. Preparar cardioversión si cae la presión arterial.

Diagnóstico Diferencial de QRS Ancho

Toda taquicardia de complejos anchos en un paciente adulto, especialmente con historia de infarto agudo al miocardio previo o miocardiopatía, debe ser manejada como Taquicardia Ventricular. Tratar erróneamente una TV como TPSV con aberrancia administrando Verapamilo causa colapso hemodinámico letal.



Con Pulso e Inestable: CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
SINCRONIZADA (100-200J).

Paso 2: Amiodarona 150mg EV en 10 min o Procainamida EV.

FÁRMACOS CLAVE EN TV Y CANALOPATÍAS

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Amiodarona	TV Monomórfica Estable	150 mg EV en 10 min -> Infusión 1 mg/min	Monitorear presión arterial.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 14

Paciente de 68 años con antecedente de infarto miocárdico previo, ingresa a urgencias por palpitaciones y mareos. PA: 110/70, FC: 160x'. ECG demuestra taquicardia regular de QRS ancho (0.15s) con ondas de captura ocasionales. La conducta más adecuada es:

- A) Administrar amiodarona 150 mg EV en 10 minutos
- B) Administrar verapamilo 5 mg EV
- C) Realizar maniobras vagales
- D) Administrar adenosina 6 mg EV bolo
- E) Alta con propranolol oral

Respuesta Correcta: A

Taquicardia de QRS ancho con capturas en paciente con infarto previo es Taquicardia Ventricular. Al estar estable, el tratamiento inicial es Amiodarona EV.

EUNACOM TIP

Ante la duda en taquicardia de QRS ancho en un adulto -> SIEMPRE tratar como Taquicardia Ventricular.
PERLAS CLÍNICAS

- Los latidos de captura y fusión en el ECG confirman el diagnóstico de Taquicardia Ventricular.